SENA E BITTAR

CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA EMPRESARIAL

Mentoria Business Medical

Documento de trabalho dos sócios

1. Os quatro pilares

PILAR	A TESE	O QUE O SISTEMA MEDE
01 Gestão	"A base. O resto se apoia nela."	Sobra do mês, depois de imposto e retirada
02 Marketing	"O paciente certo precisa te encontrar."	Pacientes novos, e quantos vieram por indicação
03 Vendas	"Consulta marcada ainda não é paciente tratado."	Tratamentos fechados, sobre os orçamentos do mês
04 Lucratividade	"Faturar mais e lucrar mais são contas diferentes."	Margem líquida do mês

E o aviso que amarra tudo: "*A agenda lota. O caixa não acompanha. Marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo.*"

O método por baixo é o dos **5 G's da Gestão Empreendedora**.

---

2. Para quem é, e para quem não é

Quatro públicos, todos donos da própria estrutura. *Vale pra toda a área da saúde.*

PÚBLICO	ESTRUTURA TÍPICA
Médico	consultório próprio ou sociedade em clínica
Dentista	consultório odontológico, sozinho ou com equipe
Biomédico	laboratório de análises clínicas, ou atuação em estética
Esteticista	clínica de estética, com ou sem formação na saúde

Os quatro pilares são os mesmos para todos. O que muda de verdade entre eles é a **conta tributária**, e a diferença é grande: médico, dentista e biomédico têm situação confirmada na reforma; estética é zona cinzenta. Isso muda o discurso de venda e

muda o trabalho.

O vocabulário do consultório também muda: procedimento, sessão, protocolo, pacote. Vale ajustar a conversa, não o método.

Não é para: profissional exclusivamente CLT ou plantonista sem estrutura própria. Sem negócio não existem os quatro pilares, e o programa vira coaching financeiro pessoal, que é outro produto.

A dor que eles trazem, em geral: trabalha mais do que nunca, a agenda está cheia, e não sobra. A promessa do programa é devolver a resposta de *onde o dinheiro está se perdendo* e fechar esse buraco em 90 dias.

Na estética a dor tem um acréscimo: além de não sobrar, o profissional quase sempre não sabe em que alíquota vai cair depois da reforma. Essa insegurança é, hoje, o melhor argumento de entrada desse público.

O que a mentoria é, e o que ela não é. A mentoria dá a **direção consultiva**. Mostra onde o dinheiro está se perdendo, qual é o caminho e em que ordem andar. **A execução é do cliente**: ninguém daqui opera a clínica, emite nota, posta conteúdo ou atende paciente. Deixar isso claro na venda evita a expectativa errada, que é a causa mais comum de cliente insatisfeito com um trabalho bem feito.

O que não prometer: faturamento garantido, número de pacientes novos, percentual de crescimento. Todo número de exemplo usado em peça fica marcado como exemplo. Manter essa disciplina na venda e na mentoria.

---

3. O formato

90 dias. É o ciclo que o Gilberto já usa e o que cabe num trimestre fiscal, o que facilita medir.

Encontro de abertura	2h, presencial ou vídeo, os dois sócios presentes
Encontros quinzenais	1h30, 6 encontros ao longo dos 90 dias
Acompanhamento entre encontros	canal direto, resposta em até 1 dia útil
Fechamento	2h, leitura dos indicadores e decisão sobre continuar

3.1 Quem é dono de quê

Cada sócio conduz o pilar que é território dele. Mais que dividir agenda, isso divide autoridade: quem fala de cada assunto é quem vive aquele assunto.

SÓCIO	ESPECIALIDADE	PILAR QUE CONDUZ
Sena	Gestão de negócios · Contábil · Tributária · Pessoal · Finanças	01 Gestão e 04 Lucratividade
Bittar	Médico estrategista · Marketing e Vendas	02 Marketing e 03 Vendas

Por que essa divisão funciona na frente do cliente. O médico sentado ali sabe diferenciar quem fala de dentro de quem fala de fora. Bittar é médico, e isso resolve a resistência que todo consultório tem a ouvir gestão de quem nunca atendeu. Sena traz a conta e a estrutura, que é onde mora o imposto e a folha, e volta depois que sobra dinheiro, que é quando a conversa deixa de ser sobrevivência e vira patrimônio.

Os dois juntos na abertura e no fechamento. No meio, cada um conduz o seu, mas os dois leem o que o outro decidiu antes do encontro seguinte. Mentoria em que um sócio desconhece a decisão do outro vira duas consultorias soltas dentro do mesmo contrato.

3.2 Cronograma dos 90 dias

DIAS	ENCONTRO	PILAR	CONDUZ	O QUE SAI DE LÁ
1 a 15	Abertura e diagnóstico	Todos	**Os dois**	Linha de base dos indicadores, mapa de classificação dos serviços e as três decisões do trimestre
16 a 30	1	01 Gestão	**Sena**	Contas separadas, pró-labore definido, rotina de fechamento com dono e data
31 a 45	2	01 Gestão	**Sena**	Regime tributário decidido, reserva de caixa com meta, folha organizada
46 a 60	3	04 Lucratividade	**Sena**	Margem por procedimento, tabela de preço revista, decisão sobre mix e convênios, e o critério do dinheiro que sobra explicado
61 a 70	4	02 Marketing	**Bittar**	Posicionamento por procedimento, origem de paciente rastreada, presença mínima viável
71 a 80	5	03 Vendas	**Bittar**	Caminho da primeira mensagem à consulta, conversa de orçamento, recall e indicação
81 a 90	6	Amarração	**Os dois**	Indicadores contra a linha de base, agenda do dono revista, desenho do próximo ciclo

Por que Lucratividade vem antes de Marketing. *Marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo.* Preço corrige margem já no mês seguinte; marketing leva um trimestre pra aparecer. Encher a agenda antes de arrumar o preço é comprar trabalho.

Depois dos 90 dias. O critério do dinheiro que sobra só vira decisão real quando a empresa já tem ponto de equilíbrio coberto e reserva formada. Antes disso, falar de investimento é conversa bonita em cima de caixa frágil. O médico sai dos 90 dias sabendo **o que perguntar e como decidir**; onde ele vai pôr o dinheiro é escolha dele, com quem for habilitado. Esse é o gancho natural do segundo ciclo.

---

4. Fase 1: diagnóstico (dias 1 a 15)

O diagnóstico do consultório. Sai um documento, não uma conversa.

4.1 A anamnese do consultório

A ficha dos 5 G's já existe e serve. O que muda para médico é o vocabulário e cinco perguntas que só fazem sentido aqui. Estas entram:

Sobre a base (Gestão)

1. A conta da clínica e a sua conta pessoal são a mesma conta? Com que frequência uma paga a despesa da outra?
2. Você sabe dizer, sem abrir nada agora, quanto sobrou no mês passado depois de imposto e da sua retirada?
3. Qual é o seu regime tributário hoje, e quem decidiu por ele?
4. Você tem pró-labore definido, ou tira conforme o caixa permite?
5. Quanto do seu faturamento vem de convênio e quanto vem de particular?

Sobre o paciente (Marketing)

6. Quando alguém te indica, a pessoa diz o quê sobre você? Por qual procedimento você é lembrado?
7. De onde veio cada paciente novo do mês passado? Você sabe ou chuta?
8. Quem responde a primeira mensagem do paciente, e em quanto tempo?

Sobre a conversão (Vendas)

9. De cada dez orçamentos que você apresenta, quantos viram tratamento?
10. O que acontece com o paciente que ouviu o orçamento e não voltou?
11. Quanto do seu faturamento vem de paciente que já era seu?

Sobre a margem (Lucratividade)

12. Qual dos seus procedimentos dá mais margem? E qual você mais faz?
13. Há quanto tempo você não reajusta preço?
14. Se a sua agenda dobrasse amanhã, o que quebraria primeiro?

Para quem faz estética (pergunta obrigatória)

15. Dos seus procedimentos, quais têm finalidade terapêutica e quais são de embelezamento? Como eles aparecem hoje na nota fiscal?

A pergunta 14 costuma ser a que abre a conversa de verdade. A 15 é a que vale mais dinheiro: a classificação do procedimento decide a conta de imposto deste consultório.

4.2 Levantamento de números

Pedir antes do encontro de abertura, para não queimar a reunião coletando dado:

- Extrato bancário da clínica dos últimos 6 meses
- Faturamento mês a mês dos últimos 12 meses, separado convênio x particular
- Guias de imposto dos últimos 6 meses
- Folha, se houver equipe
- Lista de procedimentos com preço praticado
- Agenda dos últimos 3 meses, com número de atendimentos
- Amostra de notas fiscais emitidas, para ver como o serviço está descrito hoje. É dali que sai o mapa de classificação

4.3 O que é entregue no fim da fase 1

Um documento com:

1. **A linha de base dos quatro indicadores.** Sobra do mês, pacientes novos, conversão de orçamento, margem líquida. Com o método de cálculo escrito, para que o médico saiba de onde saiu cada número.
2. **Onde o dinheiro está se perdendo.** O ranking dos vazamentos, do maior para o menor, em reais por mês.
3. **A conta do regime tributário.** Comparativo do regime atual contra as alternativas, com a conta feita.
4. **O mapa de classificação dos serviços.** Cada procedimento da tabela ligado à sua classificação, separando o que é saúde do que é embelezamento. Para médico, dentista e biomédico isso confirma o enquadramento. Para quem faz estética, isso é o trabalho principal, e é onde está o risco e o ganho.
5. **As três decisões do trimestre.** Não dez. Três.

---

5. Fase 2: plano de ação nos quatro pilares (dias 16 a 80)

Seis encontros quinzenais, com o calendário e o condutor de cada um na seção 3.2. A ordem de execução inverte a numeração dos pilares, de propósito.

Por que a ordem muda

A numeração dos pilares segue a jornada do paciente: Gestão, Marketing, Vendas, Lucratividade. Para **executar**, a ordem é outra, e o motivo está na própria tese: *marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo.*

Então: primeiro a base, depois o preço, só então o volume.

Se vocês preferirem executar na ordem numerada, é decisão de vocês. Mas o médico que entra em marketing antes de arrumar preço costuma voltar em seis meses mais cansado e com a mesma sobra.

Encontros 1 e 2: Gestão, a base

Conduz: Sena · gestão de negócios, contábil, tributária e pessoal

O que sai arrumado:

- Conta pessoa física separada da conta da clínica, de verdade, com data
- Pró-labore definido em valor, não em sobra
- Regime tributário decidido e, se for o caso, com o pedido de mudança protocolado ou agendado para a janela certa
- Rotina mensal de fechamento: quem fecha o mês, até que dia, em que planilha ou sistema
- Reserva de caixa, com meta em meses de custo fixo

Ancora no **2G, Gestão Financeira** do livro: governança, orçamento, fluxo de caixa, investimentos, endividamento, nessa ordem de pirâmide.

Encontro 3: Lucratividade, o preço

Conduz: Sena · finanças, e o critério do dinheiro que sobra

- Margem apurada por procedimento, não no agregado
- Custo real da hora do médico, incluindo a hora que ele não atende
- Tabela de preço revista, com data de reajuste definida
- Decisão sobre o mix: qual procedimento ganha agenda e qual perde
- A conta do convênio: qual convênio paga a conta e qual é prejuízo disfarçado de movimento

Esta é a sessão que costuma mudar o resultado mais rápido, porque preço corrige margem no mês seguinte, enquanto marketing leva um trimestre.

A segunda camada: o critério do dinheiro que sobra. Arrumada a margem, começa a aparecer sobra, e aí a pergunta deixa de ser quanto entra e passa a ser o que fazer com o que sobrou.

O papel do Sena aqui é **explicar a lógica**, para o médico passar a enxergar dinheiro parado como decisão e não como conforto. O que é dinheiro inteligente, por que sobra parada em conta perde valor, qual a diferença entre reserva, capital de giro e capital que pode trabalhar, e que perguntas fazer a quem for cuidar do investimento dele.

O que não acontece nesta sessão: indicação de produto, de corretora ou de aplicação específica, e nenhuma promessa de retorno. Quem decide onde põe o dinheiro é o médico, com quem for habilitado para isso. A mentoria entrega o critério, não a aplicação.

Essa delimitação é o que mantém o pilar vendável sem criar exposição. O OCEO chegou na mesma conclusão e registrou (`Projetos Gsena Tec/oceo/pilar-5-educacao-pre-investimento.md`).

Encontro 4: Marketing, o paciente certo

Conduz: Bittar · médico estrategista, marketing e vendas

- Posicionamento: por qual procedimento este médico quer ser lembrado
- Presença mínima viável, sem virar produtora de conteúdo
- Origem de paciente rastreada: de onde veio cada um, registrado na recepção
- Reputação: avaliação de paciente, indicação ativa, relacionamento com colegas que encaminham

Trava obrigatória: tudo dentro das regras do conselho. A orientação é geral, e quem responde pela própria publicidade perante o conselho é o profissional.

Encontro 5: Vendas, o paciente tratado

Conduz: Bittar

- O caminho da primeira mensagem até a consulta, cronometrado
- Quem responde, em quanto tempo, com que script
- A conversa de orçamento: como é apresentada hoje, o que muda
- O retorno do paciente que não fechou: existe ou o orçamento morre sozinho
- Recall e indicação: o paciente que volta e o paciente que traz outro

Ancora no **5G, Gestão de Clientes**: conhecimento, compra, retenção, defesa, recompra.

Encontro 6: amarração

Conduzem: os dois

- Revisão dos quatro indicadores contra a linha de base
- O que ficou pela metade e por quê
- Gestão de si: a agenda do médico, o que ele parou de fazer para isso caber (**1G**, matriz de urgente x importante)
- Desenho dos próximos 90 dias

---

6. Fase 3: acompanhamento de perto (dias 76 a 90 e adiante)

O acompanhamento de perto, em operação:

- **Painel mensal.** Os quatro indicadores numa tela só. Quanto entrou e quanto sobrou, de onde vem cada paciente, o que ajustar neste mês.
- **Uma pergunta por mês.** Qual é o ajuste deste mês. Um, não cinco.
- **Revisão trimestral.** Replica o diagnóstico e compara com a linha de base.

---

7. O que é medido, e como

Os quatro indicadores precisam de fórmula escrita, senão cada mês é medido de um jeito e a comparação não vale.

Os nomes abaixo são os do painel, letra por letra.

PILAR	INDICADOR	COMO CALCULAR
Gestão	**Sobra do mês**, depois de imposto e retirada	Receita recebida no mês, menos custo fixo, menos custo variável, menos imposto pago, menos pró-labore. É caixa, não competência.
Marketing	**Pacientes novos**, e quantos por indicação	Primeira consulta no período, por origem registrada na recepção. Paciente que volta depois de anos conta como retorno. A fatia que veio por indicação é o número que mostra reputação.
Vendas	**Tratamentos fechados**, sobre os orçamentos do mês	Orçamentos que viraram tratamento iniciado, dividido pelos orçamentos apresentados no mesmo período.
Lucro	**Margem líquida**, contra a meta do trimestre	Sobra do mês dividida pela receita do mês. É o número que mostra se faturar mais virou lucrar mais.

O painel traz ainda faturamento e lucro dos últimos 12 meses lado a lado, que é o gráfico que o médico entende sem explicação.

Medir a linha de base no diagnóstico e repetir todo mês, com a mesma conta.

---

8. Próximas peças que saem deste documento

- O modelo do documento de diagnóstico que fecha a fase 1
- A peça comercial de uma página para o médico
- O roteiro do diagnóstico gratuito

---

9. Preço

FORMA	VALOR
À vista, pix ou cartão	**R$ 50.000,00**
Parcelado	**12x de R$ 5.000,00**, total de R$ 60.000,00
